

ĐỀ CƯƠNG DINH DƯỠNG 2018

Mục lục

Câu 1: Trình bày hậu quả của thiếu hoặc thừa năng lượng:	2
Câu 2: Trình bày vai trò, nhu cầu của Prôtêin đối với cơ thể:	3
Câu 3: Trình bày vai trò, nhu cầu vitamin A trong thực phẩm:	5
Vitamin A là vitamin tan trong dầu.....	5
Câu 4: Trình bày tính cần đối của khẩu phần: năng lượng, Pr, L, G, vitamin, chất khoáng:	7
Câu 5: Trình bày đặc điểm dinh dưỡng cho người trưởng thành: năng lượng, Pr, L, G, vitamin, chất khoáng:.....	9
Câu 6: Trình bày cách thu thập số liệu, kỹ thuật, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp điều tra khẩu phần cá thể thông qua phương pháp nhớ lại 24h qua:	11
Câu 7. Trình bày nguyên tắc chung của dinh dưỡng điều trị:.....	13
Câu 8: Trình bày mục tiêu và nội dung của giám sát dinh dưỡng:	14
Câu 9: Trình bày kỹ năng tư vấn dinh dưỡng tiết chế:	16
Câu 10: Trình bày lợi ích và nguy hại của phụ gia thực phẩm:	18

Câu 1: Trình bày hậu quả của thiếu hoặc thừa năng lượng:

- Trung bình để tăng 1g thể trọng cần 8Kcal, trong đó khoảng 1/3 là khối nạc. Để tăng như vậy cần có đầy đủ protein và các chất dinh dưỡng cần thiết
- Sự tăng giảm cân luôn xảy ra đồng thời ở cả 2 khối (nạc và mỡ) tuy nhiên không phải luôn luôn ở cùng một tỷ lệ
- Cung cấp năng lượng không đủ sẽ dẫn đến hiện tượng thiếu năng lượng trường diễn ở người lớn và thiếu dinh dưỡng năng lượng protein ở trẻ em
- Sự giảm cân xảy ra đồng thời ở cả khối nạc và khối mỡ của cơ thể, mức độ giảm ở mỗi khối phụ thuộc vào 2 yếu tố : lượng mỡ tích lũy của cơ thể trước khi bị đói và số năng lượng bị thiếu. Ví dụ một người gầy khi bị đói sẽ mất lượng nitơ gấp 2 lần so với người béo
- Cung cấp vượt quá nhu cầu kéo dài sẽ dẫn đến tích lũy năng lượng thừa dưới dạng mỡ, đưa đến tình trạng thừa cân và béo phì với tất cả những hậu quả về bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường...

Câu 2: Trình bày vai trò, nhu cầu của Prôtêin đối với cơ thể:

Protein là hợp chất hữu cơ có chứa nitơ. Đơn vị cấu thành protein là acid amin. Có 22 loại acid amin hay gặp trong thực phẩm, trong đó có 9 loại acid amin cần thiết đối với người lớn gồm: Tryptophan, Lysin, Methionin, Phenylalamin, Leucin, Isoleucin, Valin, Treonin, Histidin. Trẻ em cần thêm Arginin.

Đối với những acid amin này, cơ thể người không tự tổng hợp được mà phải lấy vào nhờ thức ăn. Protein từ thức ăn có nguồn gốc động vật thường có khá đầy đủ các acid amin cần thiết và có tỷ lệ khá cân đối, đặc biệt là trong trứng và sữa nên chúng được coi là "protein chuẩn". Protein trong thức ăn có nguồn gốc thực vật thường thiếu 1 hay nhiều acid amin cần thiết nào đó, những thiếu hụt này gọi là "yếu tố hạn chế" của protein. Do đó để khắc phục cần có sự kết hợp giữa thức ăn có nguồn gốc động vật và thực vật.

a. Vai trò

- **Tạo hình:** Vai trò quan trọng nhất của protein là xây dựng và tái tạo các mô trong cơ thể. Quá trình giáng hóa và tổng hợp lại protein trong cơ thể từ 0,3 đến 0,4% hàng ngày. Quá trình đổi mới đó diễn ra khác nhau. Protein trong cơ thể mất đi 1 tỷ lệ nhỏ theo con đường da, tóc móng và qua phân.

- **Tham gia vận chuyển các chất dinh dưỡng và kích thích ngon miệng:** Phần lớn các chất vận chuyển dinh dưỡng là protein. Khi thiếu protein, việc hấp thu và vận chuyển một số chất dinh dưỡng bị ảnh hưởng dù trong khẩu phần ăn vào thực tế không thiếu chất dinh dưỡng đó.

- **Điều hòa hoạt động của cơ thể:** Protein là thành phần quan trọng cấu thành nên các hormon, các enzym, tham gia sản xuất kháng thể. Protein tham gia vào mọi hoạt động điều hòa chuyển hóa, duy trì cân bằng dịch thể.

- **Bảo vệ cơ thể và khử độc:** Con người có thể bị ảnh hưởng bởi các chất độc có trong thức ăn, nước uống, không khí nhưng cơ thể đã trung hòa và khử độc chúng ở gan nhờ protein. Khi thiếu protein, cơ thể giảm khả năng trung hòa và khử độc cũng như bài xuất chất độc khỏi cơ thể nên dễ bị tích lũy, ảnh hưởng tới các cơ quan trong cơ thể.

- **Cung cấp năng lượng:** Là nguồn năng lượng cho cơ thể khi nguồn glucid và lipid không đủ.

b. Nhu cầu

- Nhu cầu tùy thuộc vào tuổi, giới, trọng lượng cơ thể, tình trạng sinh lý, bệnh lý. Giá trị protein trong khẩu phần càng thấp đòi hỏi lượng protein càng nhiều. Chế độ ăn nhiều chất xơ làm cản trở tiêu hóa và hấp thu protein cũng làm tăng nhu cầu protein.

- Nhu cầu protein khuyến nghị tối thiểu cho người trưởng thành VN hiện nay là 1,25g/kg/ngày; Protein nên chiếm 12 - 14% năng lượng khẩu phần trong đó protein nguồn gốc động vật chiếm 30 - 50%.

- Nếu thiếu protein trong khẩu phần trường diễn cơ thể sẽ gầy, chậm lớn, chậm phát triển thể lực và trí tuệ, rối loạn nội tiết, giảm nồng độ protein trong máu, giảm khả năng miễn dịch và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng

- Nếu thừa so với nhu cầu, protein sẽ chuyển hóa thành lipid và dự trữ dưới dạng mô mỡ gây tình trạng thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch, ung thư đại trực tràng và gout.

c. Nguồn cung cấp trong thực phẩm:

Nguồn protein trong thực phẩm rất phong phú và đa dạng, cụ thể: 19% trong thịt lợn nạc, 16,5 % trong thịt nửa nạc nửa mỡ, 14.5% trong thịt lợn mỡ...

Câu 3: Trình bày vai trò, nhu cầu vitamin A trong thực phẩm:

Vitamin A là vitamin tan trong dầu.

a. Vai trò:

- **Tham gia chức năng thị giác:** là chức năng được xác định rõ nhất của vitamin A. Sự có mặt của vitamin A là phần không thể thiếu đối với đảm bảo thị giác con người. Thiếu vitamin A, những triệu chứng lâm sàng đầu tiên thường xuất hiện ở mắt, sớm nhất là quáng gà.

- **Duy trì cấu trúc bình thường của da và niêm mạc, biệt hóa tế bào:** Vitamin A giúp cho quá trình phát triển và tái tạo các tế bào da và niêm mạc, khả năng tiết dịch của các tế bào niêm mạc; kích thích quá trình phát triển của các biểu mô như mô sùng, ruột và đường hô hấp. Ảnh hưởng đặc biệt đến da, kích thích liền sẹo, phòng các bệnh của da. Thiếu vitamin A dẫn tới khô kết mạc, giác mạc.

- **Đáp ứng miễn dịch:** do hoạt động đặc hiệu lên các tế bào của cơ thể, VTM A tham gia tích cực vào sức chống chịu bệnh tật của con người. Chia ra MD không đặc hiệu (bảo vệ toàn vẹn da chống sự xâm nhập của vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh qua da) và MD đặc hiệu (duy trì, bảo vệ dòng tế bào lympho, tham gia đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào T)

- **Tạo máu:** Cơ chế chưa rõ nhưng thiếu VTM A liên quan chặt chẽ với thiếu máu do thiếu sắt.

- **Tăng trưởng:** Retinoic acid đóng vai trò như 1 hormon trong điều chỉnh sự lớn và phát triển của các mô trong hệ cơ - xương.

- **Sinh sản:** hiện tại, cơ chế hoạt động của vitamin A trong sinh sản cũng chỉ là hiệu bất ban đầu

- **Chống lão hóa:** kéo dài quá trình lão hóa do ngăn chặn sự phát triển các gốc tự do

- **Chống ung thư:** do kìm hãm của nó với các gốc tự do

- Triệu chứng đầu tiên của tình trạng thiếu vitamin A là dấu hiệu quáng gà, nếu dự trữ không bù trừ được sẽ gây rụng tóc, da khô, mất hắc thị giác

Vitamin A được tích trữ lâu dài trong cơ thể, lạm dụng gây nhiễm độc: tổn thương da, nôn mửa, viêm gan...

b. Nhu cầu:

- Nhu cầu VTM A ở trẻ dưới 1 tuổi từ 375 - 400 µg/ngày

Ở trẻ 1 - 3 tuổi là 400 µg/ngày

Ở trẻ 4- 6 tuổi là 450 µg/ngày

Ở trẻ 7 - 9 tuổi là 500 µg/ngày

Ở thiếu niên và người trưởng thành là 600 µg/ngày

- Nhu cầu tăng cao ở phụ nữ cho con bú, người mắc bệnh truyền nhiễm và người bệnh ở giai đoạn hồi phục

- Thừa VTM A thường gặp ở những trường hợp dùng VTM A liều cao, kéo dài: đau đầu, buồn nôn, rụng tóc, khô da và niêm mạc. Liều cao ở PNCT gây quái thai.

c. Nguồn cung cấp trong thực phẩm:

-Vitamin A ở thực phẩm nguồn gốc động vật dưới dạng retinol, còn thức ăn có nguồn gốc thực vật ở dưới dạng caroten

-Retinol có nhiều trong gan, lòng đỏ trứng, bơ, sữa, pho mát

-Vitamin trong gan và các mô chủ yếu tồn tại dưới dạng este

-Vitamin đã được dùng để thêm vào nhiều loại thực phẩm để cải thiện giá trị dinh dưỡng

-Caroten có nhiều trong rau có màu xanh đậm, vàng hoặc quả màu vàng như: rau ngót, gấc...

Câu 4: Trình bày tính cân đối của khẩu phần: năng lượng, Pr, L, G, vitamin, chất khoáng:

Một khẩu phần hợp lý nghĩa là:

- Cung cấp đủ nhiệt lượng theo nhu cầu cơ thể
- Có đủ các chất dinh dưỡng cần thiết
- Các chất dinh dưỡng ở 1 tỷ lệ cân đối thích hợp

1. Cân đối về năng lượng:

-Yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất trong dinh dưỡng cân đối là xác định được mối tương quan hợp lý giữa thành phần các chất dinh dưỡng có hoạt tính sinh học, chủ yếu là protein, lipid và glucid các vitamin và các chất khoáng tùy theo tuổi, giới, tính chất lao động và cách sống.

- Cân đối tỷ lệ năng lượng do P:L:G là 12:18:70 tiến tới 14:20:66. Tỷ lệ lipid không nên vượt quá 30% năng lượng khẩu phần.

-Prôteein trong khẩu phần người lao động nặng không nên dưới 10% năng lượng khẩu phần

-Chất béo nên khoảng 18 - 25% khi vượt quá 35% hoặc thấp hơn 10% đều bất lợi cho cơ thể. Nên tăng 5% cho vùng lạnh và giảm 10% cho vùng nóng.

2. Cân đối về protein

Là thành phần quan trọng nhất. Tính cân đối về protein nên có:

- Tương quan năng lượng: 1g/30 - 35 Kcal
- Tỷ số giữa protein động vật và protein tổng số, nói lên chất lượng của khẩu phần, do đó protein động vật chiếm khoảng 30 - 50% tổng lượng protein.

3. Cân đối về lipid

-Biểu hiện bằng tương quan giữa lipid động vật và lipid thực vật. Lipid thực vật nên chiếm khoảng 30 - 50% tổng lượng lipid. Việc thay thế hoàn toàn lipid thực vật là không hợp lý

-Tỷ lệ acid béo trong khẩu phần, khuyến nghị đầu tiên và quan trọng nhất là các acid béo no không được vượt quá 10% năng lượng khẩu phần. Các acid béo không no phải chiếm khoảng 4 - 10% năng lượng.

4. Cân đối về glucid

Trong điều kiện lao động thể lực giảm thì nên hạn chế glucid trong khẩu phần và tỷ lệ năng lượng nên là 50% trong khẩu phần đó nên có tinh bột 75%, glucid đơn giản 20% các chất pectin 3%, cellulose 2%. Ở nước ta, năng lượng do glucid nói chung nên là 61 - 70%, trong đó các glucid phức hợp nên chiếm 70%.

5. Cân đối về vitamin

là cân đối giữa nguồn năng lượng và các yếu tố cần thiết để giải phóng nguồn năng lượng đó trong cơ thể. Theo FAO/WHO cho 1000 KCal cần có 0,4mg B₁; 0,55 B₂; 6,6 mg PP.

6. Cân đối khoáng

Tỷ số Ca/P trong khẩu phần nên trong khoảng 0,8 - 1,5 và thay đổi theo tuổi. Sơ sinh bằng 2 như ở sữa mẹ và trẻ lớn nên bằng 1,25 như ở sữa bò. Tỷ số Ca/P cũng nói nên cân bằng kiềm toan của khẩu phần

-Tỷ số Ca/Mg trong khẩu phần nên là 1/0,6.

7. Cân đối các chất chống oxy hóa:

Đó là các Vitamin E, C, Beta caroteen, selen, Zn ...

Câu 5: Trình bày đặc điểm dinh dưỡng cho người trưởng thành: năng lượng, Pr, L, G, vitamin, chất khoáng:

1.Nhu cầu năng lượng:

*Tiêu hao năng lượng của người trưởng thành tùy theo cường độ LĐ, thời gian LĐ, tính chất cơ giới hóa và tự động hóa sản xuất, số liệu tiêu hao mang tính gần đúng

*Theo TCYTTG 1985, có thể tính nhu cầu năng lượng từ chuyển hóa cơ bản và hệ số lao động:

- Chuyển hóa cơ bản(Kcal/ngày) của **bản thân Em thuộc nhóm 30-60 nam**, sẽ tính theo công thức

$11,6 W + 879$ trong đó W là cân nặng(kg)

- Hệ số lao động: Nhẹ/rất nhẹ hệ số là 1,56, vừa hệ số là 1,75, nặng hệ số là 2,05

-Áp dụng cho bản thân **Em là sinh viên nam**, hệ số lao động là 1,75, cân nặng 60 kg vậy tổng nhu cầu năng lượng sẽ là: $((11,6 \times 60) + 879) \times 1,75 = 2756$ (Kcal/ngày)

- Chuyển hóa cơ bản(Kcal/ngày) của **bản thân Em thuộc nhóm 30-60 nữ**, sẽ tính theo công thức

$8,7 W + 829$ trong đó W là cân nặng(kg)

- Hệ số lao động: Nhẹ/rất nhẹ hệ số là 1,56, vừa hệ số là 1,75, nặng hệ số là 2,05

-Áp dụng cho bản thân **Em là sinh viên nữ**, hệ số lao động là 1,75, cân nặng 50 kg vậy tổng nhu cầu năng lượng sẽ là: $((8,7 \times 50) + 829) \times 1,75 = 2212$ (Kcal/ngày)

2.Nhu cầu prôtêin:

Theo Viện dinh dưỡng, nhu cầu thực tế về pr là 1,25g/kg cân nặng cơ thể/ngày, năng lượng do pr cung cấp từ 12-14% tổng năng lượng của khẩu phần

3.Nhu cầu lipid:

Theo Viện dinh dưỡng nhu cầu người trưởng thành, lipid chiếm 18-25% nhu cầu năng lượng của cơ thể, trong đó lipid nguồn gốc thực vật nên chiếm khoảng 30-50%. Tỷ lệ lipid động vật/lipid tổng số không nên vượt quá 60%

4.Nhu cầu glucid: Glucid chiếm khoảng 56-70% tổng năng lượng, trong đó các glucid phức hợp nên chiếm 70%

5.Nhu cầu vitamin:

***VitaminA:**

-Dạng retinol chỉ có trong thức ăn động vật. khi vào cơ thể tiền vitamin A sẽ chuyển thành vitamin A

Theo tỉ lệ 12:1 đối với hoa quả chín, 22-24:1 đối với rau xanh

-Theo FAO/WHO nhu cầu vitamin A cho người trưởng thành là 750 µg

-Theo viện dinh dưỡng nhu cầu vitamin A/ngày cho người trưởng thành là 600 µg

***Vitamin D:**

Theo viện dinh dưỡng nhu cầu khuyến nghị là 5 µg/ngày cho tất cả đối tượng, riêng đối với người 51-60 có nhu cầu 10 µg/ngày và người trên 60 tuổi có nhu cầu 15 µg

***Vitamin E:**

Nhu cầu cho người trưởng thành từ 19 tuổi trở lên là 12mg/ngày

***Vitamin nhóm B:**

Cứ 1000 kcal ăn vào, nhu cầu vitamin B1 là 0,4mg, B₂ là 0,55mg và PP là 6,6mg

***Vitamin C:**

Nhu cầu cho người trưởng thành là 70mg, chưa tính hao hụt do nấu nướng do vitamin C dễ phân hủy bởi quá trình oxy hóa, ánh sáng, nhiệt độ...

6.Nhu cầu khoáng:

***Sắt:**

Bản thân Em là Nam thuộc đối tượng ≥ 19 tuổi, khi giá trị sinh học 10% thì nhu cầu sắt là 18,3 mg/ngày

Bản thân Em là Nữ thuộc đối tượng 19-49 tuổi, khi giá trị sinh học 10% thì nhu cầu sắt là 39,2 mg/ngày

***Kẽm:**

Bản thân Em là Nam thuộc đối tượng 19-60 tuổi, khi giá trị sinh học 30% thì nhu cầu kẽm là

7,0 mg/ngày

Bản thân Em là Nữ thuộc đối tượng 19-60 tuổi, khi giá trị sinh học 30% thì nhu cầu kẽm là 4,9 mg/ngày

***Canxi:**

Theo Viện dinh dưỡng nhu cầu canxi hàng ngày cho người trưởng thành 19-49 tuổi là 700mg/ngày, từ 50 tuổi trở lên là 1000mg/ngày

***Iod:**

Nhu cầu cho người trưởng thành >19 tuổi là 150µg/ngày

***Selen:**

Bản thân Em là Nam thuộc đối tượng 19-60 tuổi, nhu cầu trung bình tổng số là 27,3mg/ngày

Bản thân Em là Nữ thuộc đối tượng 19-60 tuổi, nhu cầu trung bình tổng số là 20,4mg/ngày

(Chú ý câu này: Bản thân là Nam thì chỉ học tương ứng với dòng có chữ bản thân Em là Nam ở ý 1, sắt, kẽm, selen và Bản thân là Nữ cũng thế!!!!!!)

Câu 6: Trình bày cách thu thập số liệu, kỹ thuật, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp điều tra khẩu phần cá thể thông qua phương pháp nhớ lại 24h qua:

1. Cách thu thập số liệu:

***Đối với điều tra viên:**

Trước khi tiến hành thu thập số liệu cần được tập huấn kỹ về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc điều tra đặc biệt về kỹ thuật và kỹ năng điều tra. Phải được điều tra thử (pretest) rồi mới điều tra chính thức.

***Đối tượng được hỏi:**

-Nếu là người lớn: hỏi trực tiếp đối tượng

-Nếu là trẻ em: hỏi người trực tiếp cho trẻ ăn

***Thời gian: có 2 cách ấn định thời gian cần hỏi:**

-**Cách 1:** Hỏi ghi tất cả những thực phẩm (kể cả đồ uống) được đối tượng ăn uống trong giai đoạn 24h kể từ lúc ĐTV bắt đầu phỏng vấn trở về trước.

-**Cách 2:** Hỏi ghi tất cả những thực phẩm kể cả đồ uống được đối tượng ăn uống 1 ngày hôm trước kể từ lúc ngủ dậy buổi sáng cho tới lúc đi ngủ buổi tối.

2. Kỹ thuật:

-Trước khi phỏng vấn, điều tra viên(ĐTV) phải giải thích rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc điều tra để đối tượng hiểu và cùng cộng tác.

- Không hỏi những ngày có sự kiện đặc biệt: giỗ, tết, liên hoan....

-Bắt đầu từ bữa ăn gần nhất rồi hỏi ngược dần theo thời gian.

-Mô tả chi tiết tất cả những thức ăn và đồ uống đã được tiêu thụ, kể cả cách nấu nướng chế biến, tên thực phẩm, tên hãng thực phẩm nếu là những thực phẩm chế biến sẵn như đồ hộp, đồ gói...

-Số lượng thực phẩm tiêu thụ phải được đánh giá một cách chính xác.

=> ĐTV cần sử dụng các đơn vị đo lường thông dụng có các kích cỡ hợp lý để đối tượng có thể trả lời đúng. ĐTV phải biết các đơn vị đo lường trong gia đình, địa phương để so sánh với đơn vị chung khi cần thiết

-ĐTV có thể sử dụng: Những mẫu thực phẩm bằng nhựa hoặc tranh màu, ảnh chụp các mẫu thực phẩm=> Để giúp đối tượng dễ nhớ, dễ mô tả các kích cỡ miếng thực phẩm đã được tiêu thụ

-Luôn luôn đặt những câu hỏi kiểm tra độ chính xác của thông tin.

-Tuyệt đối tránh những câu hỏi gợi ý hoặc điều chỉnh câu trả lời của đối tượng

-ĐTV phải thông cảm, ân cần, cởi mở... nhằm tạo cho đối tượng cảm giác yên tâm, gần gũi để có thể trả lời một cách thoải mái, chính xác

-Phải luôn có trạng từ (bao nhiêu?...) hoặc tính từ (gì?...) trong khi đặt câu hỏi về các thức ăn đã được tiêu thụ.

-Ví dụ: Cơm ăn bao nhiêu bát?Loại bát gì? bát sứ Hải dương, bát Trung Quốc, Bát Tràng, bát to...

Đơm như thế nào?Nửa bát, lưng bát, miệng bát hay đầy bát?

3. Ưu điểm:

-Là 1 phương pháp rất thông dụng và giá trị khi áp dụng cho số đông đối tượng

-Đơn giản, nhẹ nhàng cho đối tượng nghiên cứu, thường có sự hợp tác rất cao

-Nhanh, chi phí thấp và có thể áp dụng rộng rãi, cả đối tượng trình độ văn hóa thấp hoặc mù chữ

4. Nhược điểm:

- Hiện tượng "trung bình hóa khẩu phần" có thể xảy ra do điều tra viên điều chỉnh khi phỏng vấn

- Đối tượng có thể nói quá lên với khẩu phần “nghèo” hoặc giảm đi với khẩu phần “giàu”

- Đối tượng có thể quên 1 cách không cố ý với những thực phẩm tiêu thụ không thường xuyên

- Không thể áp dụng cho người có trí nhớ kém

- Khó ước tính chính xác một số thực phẩm.

Câu 7. Trình bày nguyên tắc chung của dinh dưỡng điều trị:

Liệu pháp ăn uống ngày càng có vai trò đặc biệt đối với người bệnh điều trị trong bệnh viện. Chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh cần dựa vào trình trạng bệnh lý, rối loạn chuyển hóa và tập tính ăn uống của người bệnh. Khẩu phần xây dựng cho người bệnh gồm tổng số calo cần cung cấp, giá trị dinh dưỡng, cách chế biến, số bữa ăn trong ngày phải phù hợp với nhu cầu người bệnh.

Nguyên tắc chung của dinh dưỡng điều trị là:

- Người bệnh phải dùng các chế độ ăn quy định trong bệnh viện, không dùng các thức ăn mua bán hoặc mang ở ngoài vào
- Chuyên gia dinh dưỡng tiết chế cần nắm vững các loại bệnh trong bệnh viện và trên cơ sở đó xây dựng đủ các loại chế độ ăn cho mỗi loại bệnh và phổ biến cho y, bác sĩ điều trị biết để dùng cho người bệnh. Mỗi chế độ ăn nên có kí hiệu riêng để dễ gọi và xây dựng nhiều thực đơn để thay thế
- Khi xây dựng chế độ ăn phải chú ý tới mức độ trầm trọng của bệnh và các mức chi phí khác nhau cho thức ăn để người bệnh có thể lựa chọn
- Trong bệnh viện cần phải có một danh mục các chế độ ăn cơ bản để dùng cho nhiều bệnh nhân có cùng một chỉ định
- Trong bệnh viện có một số bệnh ít gặp nhưng có nhu cầu ăn uống phức tạp hoặc không chịu được một số món ăn nào đó thì phải xây dựng chế độ ăn đặc biệt
- Tất cả các y, bác sĩ trong khoa phòng điều trị đều phải coi thức ăn như là vị thuốc chủ yếu và theo dõi kết quả điều trị của liệu pháp ăn uống

Câu 8: Trình bày mục tiêu và nội dung của giám sát dinh dưỡng:

1. Định nghĩa:

Giám sát dinh dưỡng(GSDD) là 1 quá trình theo dõi liên tục nhằm mục đích cung cấp những dẫn liệu hiện có về tình hình dinh dưỡng của nhân dân và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng, từ đó giúp các cơ quan có trách nhiệm đưa ra những quyết định can thiệp kịp thời cải thiện tình trạng dinh dưỡng cộng đồng.

2.Mục tiêu:

-Mô tả tình hình dinh dưỡng của nhân dân, đặc biệt nhấn mạnh các nhóm “có nguy cơ nhất” -> cho phép xác định bản chất, mức độ của vấn đề dinh dưỡng và tiến triển của nó

-Dựa trên số liệu thu thập được, phân tích và phát hiện các vấn đề dinh dưỡng, đưa ra những dự báo tiến triển của vấn đề dinh dưỡng cho các cơ quan chức năng xây dựng đường lối dinh dưỡng thích hợp điều kiện thực tế của địa phương hay cả quốc gia. Do đó GSDD là thông tin cho hành động

-Theo dõi thường kỳ các chương trình can thiệp dinh dưỡng,đánh giá hiệu quả của các chương trình đó

-Theo dõi và đánh giá tình hình dinh dưỡng liên tục, thường xuyên nhằm có được một hệ thống số liệu trong một thời kỳ dài để có thể nhận định khuynh hướng vấn đề dinh dưỡng

3.Nội dung của GSDD:

Hệ thống GSDD nên tập trung vào trả lời những câu hỏi: Vấn đề dinh dưỡng là gì? Ai là đối tượng có nguy cơ nhất? Xảy ra ở đâu? Xảy ra khi nào? Nguyên nhân gì gây nên tình trạng ấy? Mức độ diễn biến của vấn đề?

a.Vấn đề dinh dưỡng:

- Cần xác định các vấn đề phổ biến, trầm trọng nhất. Ở các nước đang phát triển(Việt Nam), vấn đề thiếu nhiệt lượng, thiếu prô tein, thiếu máu do thiếu sắt, bướu cổ do thiếu Iod là những vấn đề phổ biến

-Bên cạnh đó cần chú ý đến các bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng như cao huyết áp, đái tháo đường, béo phì... ngày càng phổ biến hơn ở các nước trong điều kiện chuyển tiếp về kinh tế

b.Đối tượng có nguy cơ nhất:

* Thông thường do các đặc điểm sinh lý, nhu cầu dinh dưỡng, trẻ em trước tuổi đi học, bà mẹ mang thai và cho con bú là các nhóm có nguy cơ nhất

*Có thể phân lập các nhóm nguy cơ nhất theo cách su:

-Điều kiện sinh thái: Nhóm tuổi, giới, tình trạng sinh lý, tình trạng tiếp xúc với các bệnh nhiễm khuẩn và các yếu tố sức khỏe khác

-Điều kiện vật chất: Môi trường nông thôn hay thành phố, vùng sinh thái, hệ thống cung cấp thực phẩm, môi trường vệ sinh

-Điều kiện kinh tế hội hoặc văn hóa: Dân tộc, văn hóa, tình trạng kinh tế xã hội, phúc lợi

c.Phân lập các yếu tố nguyên nhân:

-Thức ăn từ khi sản xuất tới miệng người tiêu thụ đã qua nhiều giai đoạn khác nhau, bất kỳ trở ngại trên dây chuyền đó có thể ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng. Tình hình dinh dưỡng của một cá thể phụ thuộc vào số lượng và chất lượng các chất dinh dưỡng ăn vào, các chất này phụ thuộc vào mức tiêu thụ thực phẩm của gia đình, mức tiêu thụ này lại là hàm số của mức thu nhập, giá cả lương thực thực phẩm

-Dựa vào ô hình nguyên nhân liên quan tới tình trạng dinh dưỡng để xác định các yếu tố nguyên nhân ở cộng đồng hay chuỗi hiện tượng liên quan từ sản xuất lương thực thực phẩm đến tình trạng dinh dưỡng để phát hiện nguyên nhân

d.Diễn biến của vấn đề dinh dưỡng:

- Giám sát dinh dưỡng luôn theo dõi iên tục những thay đổi trong các điều kiện kinh tế, sinh thái và sản xuất lương thực thực phẩm: chế độ ăn dựa vào tự cung tự cấp dần dựa vào thị trường và công nghiệp chế biến thực phẩm, cơ cấu bữa ăn thay đổi, lượng đường, chất béo, thức ăn động vật. Những thay đổi đó kèm theo hậu quả sức khỏe

-Theo dõi những chương trình can thiệp dinh dưỡng, phát triển cộng đồng, cải thiện môi trường tác động đến dinh dưỡng

-Theo dõi và dự báo những thay đổi tập tính và thói quen ăn uống, chế độ ăn liên quan đến những bệnh mạn tính không lây có liên quan đến dinh dưỡng

Câu 9: Trình bày kĩ năng tư vấn dinh dưỡng tiết chế:

1.Kỹ năng làm quen và phân tích bệnh nhân:

- Đây là kĩ năng cần thiết đầu tiên cho công việc tư vấn bệnh nhân(BN).
- Cán bộ tư vấn cần gặp gỡ, liên lạc và nói chuyện với BN
- Thông tin: tuổi, giới, trình độ giáo dục, kiến thức, quan điểm và hành vi ăn uống liên quan đến bệnh.
- Bằng những câu hỏi phù hợp với tuổi, giới, bệnh tật bệnh nhân

2.Kỹ năng lắng nghe:

- Kỹ năng lắng nghe giúp cán bộ tư vấn hiểu rõ hơn BN
- Thông qua: lắng nghe, thông cảm và quan sát BN

Làm thế nào để lắng nghe tốt ?:

- Thể hiện sự thông cảm, tôn trọng và quan tâm đến những điều bệnh nhân đang nói.
- Tránh biểu thị sự khó chịu, buồn bực và mệt mỏi. (nhất là người già, BN năng)

3.Kỹ năng quan sát:

- Thường sử dụng khi đến thăm gia đình bệnh nhân hoặc tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.
- Nên nhìn toàn cảnh gia đình, đồ dùng, môi trường xung quanh, quan sát cách ứng xử của người nhà bệnh nhân và ngược lại

4.Kỹ năng cung cấp thông tin:

- Chỉ cung cấp thông tin hoặc nói cho gia đình bệnh nhân những gì họ nên làm.
- Cán bộ tư vấn nên lắng nghe họ và sau đó trao đổi các thực hành mà họ có thể sử dụng trong hoàn cảnh cụ thể của họ.
- Các thông tin: các kỹ năng chế biến thực phẩm(TP), cách lựa chọn TP, các phương pháp mới để nuôi dưỡng trẻ suy dinh dưỡng, những ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng một loại TP nào đó.
- Nên sử dụng mô hình, tranh lật để BN dễ hiểu hơn.

- Cung cấp thông tin nên từ từ, ít một, mỗi lần chỉ nên giới hạn 1-2 thông tin để tránh quá tải cho BN
- Nên sử dụng câu hỏi mở để kiểm tra người bệnh có thực sự hiểu những điều cán bộ tư vấn nói không
- Nên đưa ra những lời khen ngợi và những gợi ý để bệnh nhân tự quyết định hành động.

5.Kỹ năng xây dựng niềm tin:

- Nghe và ghi nhận những điều mà người bệnh nghĩ hoặc cảm thấy với thái độ chia sẻ và thông cảm.
- Phát hiện và khen ngợi những hành vi tốt sẵn có của người bệnh.
- Hướng dẫn cụ thể nơi mua thực phẩm, giá cả, chủng loại, hãng sản xuất, số lượng và cách chế biến món ăn.
- Sử dụng các từ ngữ, lời nói ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với hoàn cảnh của người bệnh. Tránh dùng các từ ngữ chuyên môn, khó hiểu.
- Nêu các giải pháp và khuyến nghị cho bệnh nhân lựa chọn
- Khuyến BN nên làm và cần nói rõ làm như thế nào.

6.Những sai có thể xảy ra trong quá trình thực hiện tư vấn:

- Những sai sót có thể không được xác định rõ ràng hoặc không đo lường được.

VD: Chỉ chú ý giảm số lượng chất béo hoặc các sản phẩm giàu chất béo ăn vào mà không chú ý giảm tổng năng lượng ăn vào hoặc bệnh nhân lại tăng sử dụng tinh bột. Do vậy bệnh nhân vẫn tăng cân, tăng triglycerid trong máu.

Câu 10: Trình bày lợi ích và nguy hại của phụ gia thực phẩm:

1. Định nghĩa:

Phụ gia thực phẩm là những chất không được coi là thực phẩm hoặc một thành phần của thực phẩm. Phụ gia thực phẩm có ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng, được chủ động cho vào với mục đích đáp ứng yêu cầu công nghệ trong quá trình sản xuất, chế biến, xử lý, bao gói, vận chuyển, bảo quản thực phẩm. Phụ gia thực phẩm không bao gồm các chất ô nhiễm hoặc các chất bổ sung vào thực phẩm với mục đích tăng thêm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm

2. Lợi ích của phụ gia thực phẩm:

Hiện nay có khoảng 600 chất phụ gia trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Ở Mỹ, mỗi năm sử dụng tới trên 30.000 tấn chất phụ gia thực phẩm, tính theo đầu người, trung bình 1,5kg/người/năm.

Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa các ngành sản xuất, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm cũng phong phú, đa dạng, tạo nhiều mặt hàng thực phẩm khác nhau. Việc sản xuất ra các loại thực phẩm mới, thay thế cho các thực phẩm tự nhiên, rất cần các chất phụ gia.

Các tác dụng tích cực của các chất phụ gia thực phẩm bao gồm:

- Tạo được nhiều sản phẩm phù hợp với ở thích và khẩu vị của người tiêu dùng
- Giữ được chất lượng toàn vẹn của thực phẩm cho tới khi sử dụng
- Tạo sự dễ dàng trong sản xuất chế biến thực phẩm và tăng giá trị thương phẩm hấp dẫn trên thị trường
- Kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm.

3. Những nguy hại của phụ gia thực phẩm:

- Ở Việt Nam hiện nay, tình trạng sử dụng phụ gia trong chế biến và bảo quản thực phẩm đang có rất nhiều bất cập, đặc biệt rất khó khăn trong việc kiểm soát. Các nhà sản xuất và chế biến thực phẩm hoặc là dùng các phụ gia ngoài danh mục, những phụ gia đã bị cấm, hoặc là dùng quá giới hạn, dùng không đúng cho chủng loại thực phẩm. Ví dụ như: dùng muối diêm

tiêu sát vào thịt quay, dùng phẩm màu ngoài danh mục cho các thực phẩm ăn ngay tới 36 - 51%.... Do vậy, đã có nhiều vụ ngộ độc thực phẩm do phụ gia thực phẩm ở các địa phương.

Những nguy hại thường gặp của phụ gia thực phẩm bao gồm:

- Gây ngộ độc cấp tính: Nếu liều lượng chất phụ gia được dùng quá giới hạn cho phép nhiều lần
- Gây ngộ độc mạn tính: Dùng liều nhỏ, thường xuyên liên tục, một số chất phụ gia tích lũy trong cơ thể, tổn thương cơ thể. Ví dụ, khi sử dụng thực phẩm có hàn the, hàn the sẽ được đào thải qua nước tiểu 81%, qua phân 1%, qua mồ hôi 3%, còn 15% được tích lũy trong các mô mỡ, mô thần kinh, dần dần tác hại trên nguyên sinh chất và đồng hóa các Albuminoit, gây ra hội chứng ngộ độc mạn tính (mất cảm giác ngon miệng, giảm cân, tiêu chảy, rụng tóc, suy thận mạn, da xanh xao, động kinh...)
- Nguy cơ hình thành khối u, ung thư, đột biến gen, quái thai: Một số chất phụ gia tổng hợp có khả năng gây các hậu quả trên. Do vậy chỉ cần khi phát hiện 1 chất phụ gia nào đó gây ung thư ở 1 loài động vật thí nghiệm, dù ở liều lượng nào cũng sẽ bị cấm sử dụng cho người.
- Nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm: Một số chất phụ gia sử dụng để bảo quản thực phẩm đã phá hủy một số chất dinh dưỡng và vitamin của thực phẩm. Ví dụ như dùng oxy già để bảo quản sữa sẽ cô lập nhóm thiol và làm mất tác dụng sinh lý của sữa...